Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Carazinho

Rua Bento Gonçalves, 151 - Bairro: Vargas - CEP: 99500000 - Fone: (54)3046-9878 - Email: frcarazinh2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5005530-42.2022.8.21.0009/RS

AUTOR: ALBERI PORTES DA SILVA

RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos etc.

I – Relatório (artigo 489, inciso I, do Código de Processo Civil)

ALBERI PORTES DA SILVA, qualificado na inicial, ajuizou "AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS" contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** igualmente qualificado, aduzindo ter sido diagnosticado com câncer de rim de células claras (CID 10 C 64) em estágio clínico IV, necessitando fazer uso de VOTRIENT (PAZOPANIB) 400MG, dois comprimidos ao dia, totalizando 60 comprimidos por mês. Asseriu sobre a urgência do pedido, considerando o risco de vida que corre caso não lhe seja fornecido o medicamento. Alegou ser pobre, não possuindo condições para arcar com os custos do medicamento, eis que percebe somente R$1.818,00 proveniente de sua aposentadoria. Discorreu acerca da fundamentação jurídica que embasa seu pedido. Requereu a concessão de tutela de urgência para que o demandado oferecesse o tratamento proposto, e, ao final, a procedência da ação, para tornar definitiva a tutela de urgência. Pugnou pela gratuidade judiciária. Juntou documentos (evento 1, INIC1 e anexo).

Deferida a gratuidade judiciária e determinada a inclusão da União no polo passivo (evento 3, DESPADEC1).

Concedida a tutela provisória de urgência antecipada incidental (evento 11, DESPADEC1).

Citado, o Estado apresentou contestação ao evento 47, CONT1. Em preliminar, sustentou que a incumbência do tratamento em questão não cabe ao Estado, pois de disponibilização pelos CACONs, com responsabilidade da União. Argumentou a ilegitimidade passiva do Estado com responsabilidade exclusiva da União. No mérito, ressaltou que o tratamento do câncer é feito pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia — CACONs. Frisou que a parte autora já estava recebendo atendimento no hospital credenciado junto à rede pública para fornecimento de tratamento oncológico. Pleiteou o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito, sem resolução de mérito, ou, alternativamente, a improcedência.

Em saneador, foi homologado as contas prestadas ao evento 51, COMP1 e evento 75, OUT1, foi refutada a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo Estado e foram instadas as partes sobre as provas (evento 80, DESPADEC1).

O Estado pugnou pela produção de prova documental (evento 84, PET1). A parte autora, silenciou-se (evento 89).

A prova solicitada pela parte ré aportou no evento 101, EMAIL1.

Houve manifestação do réu, reiterando sua ilegitimidade, uma vez que o tratamento perseguido não é fornecido em razão de atraso injustificável do Ministério da Saúde (evento 105, PET1).

O Ministério Público, em parecer de mérito, opinou pela procedência do pedido (evento 109, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

II – Fundamentação (artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil)

<u>Do Julgamento Antecipado</u>

Diante dos limites aos quais se restringiu a controvérsia, dispensável a produção de outras provas, sendo suficientes aquelas que já se encontram nos autos. Outrossim, devidamente intimadas, apenas a parte ré requereu a produção de provas, a qual foi deferida ao evento 91, DESPADEC1. Portanto, cabível o imediato julgamento da lide, fulcro no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil..

<u>Da Preliminar</u>

Quanto a nova manifestação da parte ré no evento 105, PET1, onde reitera a ilegitimidade passiva do ente estatal na presente ação de medicamentos, sob o fundamento de que o fármaco só não é fornecido pelo hospital visto o atraso injustificável do Ministério da Saúde, ressalto a decisão do evento 80, DESPADEC1.

Ainda, mesmo que o fornecimento deveria ocorrer pelo Ministério da Saúde, a Portaria 876/2013 não estabelece a responsabilidade de cada ente público no aludido custeio. Nesse sentido:

> ***Ementa:*** *AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS. PAZOPANIBE (VOTRIENT®). INCORPORAÇÃO PELA CONITEC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RENAME. APLICAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NO TEMA N. 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA INCLUSÃO DA UNIÃO. 1. Diante dos diversos processos em que houve modificação da competência da Justiça Estadual para Justiça Federal, acarretando conflitos negativos de competência perante o Superior Tribunal de Justiça, restou admitido o Incidente de Assunção de Competência n. 14 pela Corte da Cidadania. Ao fim, em 18/04/2023, firmada tese que, em suma, não se permite, em qualquer hipótese, a inclusão da União no polo passivo pelo Juízo Estadual. Porém, no dia imediatamente posterior, 19/04/2023, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal referendou, por unanimidade, a decisão liminar deferida em 17/04/2023 no RE n. 1366243 - Tema n. 1234 -, pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, restando decidido, em síntese, que (5.1) nas ações judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados haverá hipótese de litisconsórcio passivo necessário do ente responsável financeiro, ainda que modifique a competência jurisdicional (observação acerca da imperativa análise de eventual tutela de urgência) e (5.2) já naquelas demandas relativas a medicamentos não incorporados, manter-se-á o feito na Justiça Estadual ou Federal eleita pelo cidadão, até o julgamento definitivo do Tema n. 1234. Ainda, (5.3) vedada a desconstituição de sentenças proferidas até 17/04/2023, por inobservância dos itens anteriores. Sob esse prisma, cogente a adoção, pelo Poder Judiciário, das diretrizes estabelecidas pelo Tribunal Guardião da Constituição que, não se há olvidar, possui hierarquia jurisdicional sobre a Corte da Cidadania. 2. In casu, a parte autora foi dignosticada com carcinoma renal de células claras e necessita do fornecimento do medicamento Pazopanibe (Votrient®), o qual, embora tenha tido sua incorporação aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), por meio de relatório publicado em 2018, não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), cuja atualização é de responsabilidade da CONITEC, conforme estabelecido pelo Decreto n. 7.646/2011. Cumpre destacar que o art. 39 da Portaria n. 140, de 27 de fevereiro de 2014, do Ministério da Saúde não se mostra suficiente para o condão de considerar todos os medicamentos oncológicos como padronizados no SUS. Até mesmo o art. 8º da Portaria n. 876/2013, conquanto disponha competir ao Ministério da Saúde "garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes, de acordo com as suas responsabilidades" (grifei), deixa de estabelecer acerca da responsabilidade de cada ente público no aludido custeio. Sob esse prisma, no afã de identificar quais são, dentro das diversas portarias do Ministério da Saúde, os medicamentos efetivamente padronizados no SUS, não se vislumbra que os fármacos antineoplásicos incorporados ou não pela CONITEC, mas sem disposição na RENAME, possam atrair o litisconsórcio passivo necessário da União, ao menos até o julgamento de mérito do Tema n. 1234 pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Considerando, portanto, que não se tem conhecimento de qual seria o ente público responsável pelo financiamento, pode ser dito que se trata de medicamento não padronizado, motivo pelo qual deve o feito ser processado e julgado pela Justiça, Estadual ou Federal, ao qual foi direcionado pelo cidadão na hora do ajuizamento da ação - neste caso, a Estadual -, na medida em que a hipótese se enquadra no item "5.2" da aludida liminar (Tema n. 1234). Nesse passo, superada a hipótese de redirecionamento contra a União, assevera-se que eventuais alegações acerca de alto custo do tratamento não amparam a pretensão recursal, pois a preservação da saúde autoriza determinação judicial para que os recursos públicos sejam direcionados a uma situação singular, em face do sopeso dos bens jurídicos a resguardar. Ademais, há nos autos documentos médicos elaborados pelo médico que assiste a parte autora e outros elementos juntados aos autos que são suficientes para o convencimento do juízo. Manutenção da decisão agravada. Revogação da ordem de emenda da petição inicial determinada em sede de cognição sumária recursal. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 50209451020238217000, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 31-05-2023)*

Diante disso, considero que já restou reconhecida a legitimidade da parte ré para figurar no polo passivo da demanda.

<u>Do Mérito</u>

O artigo 196 da Constituição Federal ressalta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, dever esse que vem corroborado também no artigo 198, §1º, e no artigo 23, inciso II, ambos da Carta Magna, bem como no artigo 241 da Constituição Estadual/RS:

> ***Art. 23.*** *É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:*
>
> *(...)*
>
> *II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;*
>
> ***Art. 196.*** *A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.*
>
> ***Art. 198.*** *§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (<u>Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000</u>).*
>
> ***Art. 241.*** *A saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.*

Além disso, a saúde é direito fundamental, elencada dentro dos direitos sociais (artigo 6º, *caput,* da Constituição Federal[1]), assim, possui aplicação imediata e incondicionada, na forma do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal, dispositivo que a ela se estende.

Portanto, é plenamente possível exigir de todos ou de qualquer um dos entes (União, Estado ou Município) - que possuem responsabilidade solidária – os medicamentos nos casos de extrema necessidade e por aqueles que não possuem condições de arcar com as despesas correspondentes – **como é o caso da parte autora, considerando que recebe mensalmente o valor líquido de aproximadamente R$ 1.818,00 (evento 1, CHEQ7) e o custo com o tratamento atinge em torno de R$ 30.000,00 a cada 90 dias.**

Nessa direção, decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento recente, proferido sob o rito do art. 543-C do anterior Código de Processo Civil:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.* ***O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto***

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. *(RE 855178 RG / PE. Repercussão geral no Recurso Extraordinário. Ministro Luiz Fux. Julgado em 05/03/2015).*

Além disso, tal tema foi inúmeras vezes objeto recorrente em julgamentos realizados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, conforme precedente ora colacionado:

Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. ***Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde.*** *Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070). Grifei.*

Mister registrar que não se pode admitir que o Judiciário reste inerte no caso de descumprimento da lei, devendo intervir se for impulsionado. Não há, portanto, violação à independência dos poderes quando da concessão de medicamentos judicialmente.

Não fosse por isso, a precária situação no orçamento do Estado não pode justificar a negativa a um direito à saúde, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal), que deve prevalecer.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJ/RS

EMBARGOS INFRINGENTES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. APLICAÇÃO IMEDIATA E INCONDICIONADA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. As despesas com a saúde para pessoas carentes devem correr por conta dos recursos destinados ao fundo de desenvolvimento social do estado (Leis Estaduais 9.908/93 e 9.828/93). Saúde é direito de todos e dever do estado e do município (art. 241, CE). Elevado à condição de direito social fundamental do homem, contido no art. 6º da CF, declarado por seus artigos 196 e seguintes, é de aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da c. Federal, que dá ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas. O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- rel. Min. Marco Aurélio). O artigo 196 da Constituição Federal não faz distinção entre os entes federados, de sorte que cada um e todos, indistintamente, são responsáveis pelas ações e serviços de saúde, sendo certo que a descentralização, mera técnica de gestão, não importa compartimentar sua prestação. Embargos acolhidos, por maioria. (Embargos Infringentes Nº 70030244370, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 19/06/2009).

AGRAVO. APELAÇÕES CÍVEIS DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTOS. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. O direito à saúde é assegurado a todos, devendo os necessitados receber do ente público o medicamento necessário. Aplicação do artigo 196 da Constituição Federal. O Estado e o Município possuem legitimidade passiva para a demanda visando o fornecimento de medicamentos a necessitado, devendo responder pelos medicamentos pleiteados no processo. Posição do 11º Grupo Cível. Precedentes do TJRGS, STJ e STF. DEFENSORIA PÚBLICA. MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em relação ao Município, sendo a Defensoria Pública um órgão do Estado do Rio Grande do Sul e a ação ajuizada também contra Município, ausente confusão entre credor e devedor. Agravo desprovido. (Agravo Nº 70039339122, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 11/11/2010)

No caso *sub judice,* a parte autora demonstrou a necessidade do medicamento postulado em virtude da patologia apresentada, **câncer de rim de células claras, em estágio clínico IV**, conforme atestados médicos do evento 1, ATESTMED10 e evento 9, ATESTMED2, que ressaltam a necessidade do uso contínuo da medicação PAZOPANIB 400 mg (VOTRIENT). Insta mencionar que o médico da parte autora frisou que a medicação é a melhor forma de tratamento para o controle da doença citada, não havendo similar no mercado, assim como não há possibilidade de substituição por qualquer outra, sendo o único que apresenta benefícios para o caso do autor.

Ademais, não se pode olvidar do fato de que o médico que acompanha a parte autora tem plena convicção de qual fármaco se adapta melhor ao tratamento clínico em questão. Por seu turno, não produziu o demandado prova capaz de contrapor ao atestado, no sentido de que a autora poderia valer-se de outros tratamentos que não o postulado

Por oportuno, e conforme já asseverado na decisão inicial, o referido medicamento possui registro na ANVISA (nº 1006811360010) e, inobstante a alegação de que foi incluído para dispensação pelo Sistema Único de Saúde, **não consta na listagem da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME, não tendo sido incorporado à política do SUS para tratamento da doença do autor.** Consequentemente, a legitimidade passiva não seria do Estado na presente demanda, afastando a competência da Justiça Estadual, enquadrando-se no item 5º da conclusão do STF. Ainda, friso que, de acordo com o artigo 19-Q da Lei 8.080/90, *"A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS"*. Assim, não competindo aos Estados e aos Municípios a inclusão, por certo que não podem ser obrigados, isoladamente, a custear tratamento sem que tenham a mínima orientação técnica do Ministério da Saúde.

No âmbito do STF, o entendimento mais recente é justamente nesse sentido, conforme se verifica dos seguintes precedentes: *RE n° 1.321.423/RS, Rel.* **Min. Dias Toffoli**, *julgado em 30/04/2021; ARE nº 1.285.333/PR, Rel.* **Min. Gilmar Mendes**, *DJe de 22/3/21; ARE nº 1.298.325/PR, Rel.* **Min. Edson Fachin**, *DJe de 18/2/21; RE nº 1.303.165/PR, Rel.* **Min. Roberto Barroso**, *DJe de 17/2/21 e ARE nº 1.301.670/PR, Rel.* **Min. Alexandre de Moraes**, *DJe de 7/1/21.*

No entanto, houve a instauração de Incidente de Assunção de Competência (IAC) perante o STJ, visando unicamente decidir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas. A delimitação da tese controvertida foi a seguinte:

Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal.

Nesse sentido, a Primeira Seção, no julgamento da Questão de Ordem suscitada nos Conflitos de Competência n. 187.276/RS, n. 187.533/SC e n. 188.002/SC, determinou expressamente que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, em atenção ao princípio da segurança jurídica, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual.

Dessa feita, procede a presente demanda para, confirmando a tutela de urgência do evento 11, DESPADEC1, determinar que o réu forneça o medicamento citado na inicial, na quantia indicada nos atestados, para o tratamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores do Estado para aquisição do medicamento (art. 538, §3º, c/c art. 500, do Código de Processo Civil).

Por fim, observando-se o que estabelece o Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde[2], de 15/5/2014, ressalto a necessidade do paciente apresentar relatórios médicos periodicamente perante a Secretaria de Saúde.

III – Dispositivo (artigo 489, inciso III, do Código de Processo Civil)

EM FACE DO QUE FOI EXPOSTO, *confirmando a tutela de urgência do Ev. 11*, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo **PROCEDENTE** o pedido aduzido por **ALBERI PORTES DA SILVA** contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** para condenar o réu a fornecer ao autor o medicamento PAZOPANIB 400 mg (nome comercial VOTRIENT), de acordo e na quantia indicada nos atestados juntados ao feito, para o tratamento contínuo e pelo tempo necessário, sob pena de ser determinado o sequestro de valores para aquisição do medicamento, atentando-se ao Enunciado nº 2 da I Jornada de Direito da Saúde.

Sucumbente, condeno o réu ao pagamento da Taxa Única e despesas, além de honorários à advogada da parte autora, que fixo em 12% sobre o valor da causa atualizado, fulcro no artigo 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação da demanda. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA-E (REsp. nº 1.270.439/PR) a partir da publicação desta decisão, acrescidos de juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97), a contar da data do trânsito em julgado da sentença. Diante do ajuizamento da presente demanda após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 14.634/14, fica o réu isento da taxa única, a teor do artigo 5º, inciso I, isenção que não abarca as despesas processuais (artigo 14 da referida Lei), que deverá restituir em caso de adiantamento pela outra parte, inclusive a título de pagamento da taxa única, fulcro no IRDR 13 do TJ/RS. Ainda, o Estado é isento da condução de Oficial de Justiça (despesa).

Interposto recurso de apelação por quaisquer das partes, considerando que não há mais juízo de admissibilidade em primeiro grau, observando-se o artigo 1.010 do Código de Processo Civil[3], intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. No caso de haver recurso adesivo, intime-se a parte apelada para contrarrazões no mesmo prazo. Após, dê-se vista ao Ministério Público e então subam os autos imediatamente ao E. TJ/RS.

Revendo posicionamento até então adotado, passo a entender que decorrido o prazo para recurso voluntário, sem a sua interposição, **dispensável o reexame necessário**, nos termos do artigo 496, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, já que a sentença está fundada em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recursos repetitivos[4].

Com o trânsito em julgado, nada mais pendente, dê-se baixa.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimação eletrônica agendada.

Documento assinado eletronicamente por **CAROLINE SUBTIL ELIAS, Juíza de Direito**, em 18/7/2023, às 14:21:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10042212430v22** e o código CRC **bdb35bf0**.

---

1. Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 2000) ↩
2. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/28564:jornada-aprova-45-enunciados-para-auxiliar-em-decisoes-da-justica-na-area-da-saude>. Acesso em: 25/5/2014. ↩
3. Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:I - os nomes e a qualificação das partes;II - a exposição do fato e do direito;III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;IV - o pedido de nova decisão.§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. ↩
4. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS À SAÚDE E À VIDA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 196 DA CF E 241 DA CE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. RUBRICA ORÇAMENTÁRIA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO, AO FADEP. REDUÇÃO. CABIMENTO. [...].. REEXAME NECESSÁRIO: Descabe reexame necessário quando a sentença estiver pautada em jurisprudência do plenário do STF ou em súmula de Tribunal Superior Competente, consoante determina o parágrafo 3º, do art. 475, do CPC. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70065928178, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 09/09/2015)APELAÇÕES CÍVEIS, AGRAVO RETIDO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PROSSO, OSTEOBAN, ARTROLIVE E LYRICA. PACIENTE PORTADORA DE POLIARTROSE NÃO ESPECIFICADA E OSTEOPOROSE NÃO ESPECIFICADA (CID-10 M15.9 E M81.9). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO, FORNECIDO PELO SUS. DESCABIMENTO. PROTOCOLO CLÍNICO. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. SUFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. Reexame necessário. 1. Descabe o reexame necessário, porquanto a sentença que determinou o fornecimento de medicamentos está fundada em decisão do plenário do STF. [...]. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO DO ESTADO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066300096, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 11/09/2015)APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. [...].. Reexame necessário. Não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, modo obrigatório, a sentença fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal, ou do tribunal superior competente. Inteligência do art. 475, § 3º, do Código de Processo Civil. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70066248014, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiç Julgado em 08/09/2015) ↩